

## Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

Vamos dar continuidade ao nosso estudo de infectologia, agora abordando as **infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)** além do HIV. Este é um tema extremamente cobrado em provas de residência, então vale a pena dominar bem cada detalhe.

---

### Classificação das Úlceras Genitais

Quando estamos diante de uma **úlcera genital**, precisamos raciocinar de forma sistemática. Primeiramente, observe se a lesão é **vesicobolhosa** — nesse caso, pense em **herpes genital**. Se for uma lesão ulcerada recente, com menos de quatro semanas de evolução, avalie as características: se for **única e indolor**, o diagnóstico provável é **sífilis**; se forem **múltiplas, dolorosas e acompanhadas de bubão** (linfonodomegalia inguinal), pense em **cancroide**.

Por outro lado, se a úlcera tem mais de quatro semanas de evolução, temos dois cenários principais. Se houver **linfonodomegalia com fistulização múltipla**, associada a proctocolite e sinais sistêmicos intensos, o diagnóstico é **linfogranuloma venéreo**. Se a lesão for **extensa e bilateral**, com aspecto "em espelho", pense em **donovanose**.

**Comentário crítico:** Essa classificação temporal e morfológica é fundamental para a prova. A banca adora colocar um caso clínico e pedir o diagnóstico diferencial baseado nas características da úlcera.

---

## Síndrome do Corrimento Genital

O corrimento genital pode originar-se da vagina ou manifestar-se como **uretrite e cervicite**. As uretrites e cervicites dividem-se em **gonocócicas e não gonocócicas**. Das não gonocócicas, aproximadamente metade é causada por **Chlamydia trachomatis**, e a outra metade por mycoplasma, tricomonas e ureaplasma.

Na prática clínica, a diferença é marcante: a uretrite **não gonocócica** apresenta sintomas **discretos, subagudos e arrastados** — não é aquela apresentação dramática com muito corrimento e ardência intensa. Já a **gonocócica** é escandalosa: corrimento **agudo e mucopurulento**, chamando muita atenção.

Quanto aos corrimentos vaginais, podem ser não infecciosos, endógenos ou IST. Dos endógenos, temos a **candidíase**, com corrimento grumoso, sem odor e muito prurido vulvovaginal. A **vaginose bacteriana** apresenta corrimento acinzentado, bolhoso, com **teste de Whiff positivo** (teste das aminas). A **tricomoníase**, que é uma IST, caracteriza-se por corrimento **amarelo-esverdeado, bolhoso e de odor fétido**.

---

## Sífilis

A **sífilis** é causada pelo **Treponema pallidum** e transmite-se por via sexual, contato com lesões e secreções infectantes, além da transmissão vertical.

A classificação temporal é essencial: a **sífilis recente** engloba os casos com até um ano de evolução, subdividindo-se em primária, secundária e latente recente. A **sífilis tardia** inclui os casos com mais de um ano, podendo ser latente tardia ou terciária.

### Sífilis Primária

O período de incubação é de aproximadamente três semanas. A lesão característica é o **cancro duro** (ou protossifiloma): uma úlcera **única, indolor**, rica em treponemas, com base endurecida e fundo limpo — observe que não há pus nem sangramento.

Pode ocorrer em qualquer local de inoculação: pênis, vagina, períneo, região anal ou até mesmo na boca.

Acompanha-se de **linfadenopatia regional não dolorosa** e, aspecto fundamental, **desaparece espontaneamente em três a oito semanas**, mesmo sem tratamento. Aqui mora o perigo: o paciente vê a lesão sumir, acha que não era nada porque não doía, e não procura atendimento.

**Pegadinha de prova:** A banca adora perguntar sobre as características do cancro duro. Lembre-se: único, indolor, fundo limpo, desaparece sozinho.

## Sífilis Secundária

Após a cicatrização do cancro duro, entre seis semanas e seis meses depois, inicia-se o **secundarismo**, que pode durar até um ano. Começa com **exantema macular** em tronco e raiz dos membros — a famosa **roséola sífilítica**. Progressivamente, surgem **pápulas eritematosas** disseminadas, com característica marcante: **acometem região palmar e plantar**.

Tardamente aparecem os **condilomas planos** (lesões papulosas verrucosas que lembram HPV), **alopecia em clareira**, **madarose** (queda de sobrancelhas) e **sifíides elegantes** (lesões mais granulomatosas).

Durante todo o quadro, há **poliadenopatia**, com destaque para os **linfonodos epitrocleares** — este é um achado muito valorizado em prova. Pessoa jovem com exantema, linfonodo epitroclear, febre baixa e mal-estar deve levantar a suspeita de secundarismo.

**Pegadinha importante:** Não caia na armadilha de achar que neurosífilis e sífilis ocular são exclusivas da fase terciária. Podem ocorrer em qualquer fase, inclusive na secundária.

## Sífilis Terciária

Décadas após a infecção não tratada, em 15 a 25% dos casos, surge o terciarismo, marcado por **destruição tecidual**. As **gomas sífilíticas** são lesões granulomatosas com necrose central, pobres em treponemas – são lesões imunomediadas. Podem acometer pele, mucosas, ossos, sistema nervoso central e grandes vasos, causando **neurossífilis** e **aortite sífilítica**.

---

## Diagnóstico da Sífilis

Os **exames diretos** visualizam o treponema. O principal é o **exame em campo escuro**: coleta-se material da lesão primária ou secundária (ricas em treponemas), coloca-se na lâmina e, com iluminação especial, visualizam-se os treponemas dourados sobre fundo escuro. Se positivo, fecha o diagnóstico. Se negativo, não descarta – continue investigando com sorologia. Não é recomendado para lesões orais devido à contaminação da cavidade bucal.

Os **exames indiretos** são os testes sorológicos, divididos em **treponêmicos** e **não treponêmicos**.

Os **testes treponêmicos** (CMIA, FTA-Abs, TPHA, teste rápido) detectam anticorpos contra o treponema e **permanecem positivos para sempre** após a infecção. Portanto, não servem para triagem em pacientes que já tiveram sífilis previamente tratada.

O **teste não treponêmico** principal é o **VDRL**, que detecta anticorpos contra células infectadas. Aqui vale entender o conceito de titulação: é o processo de diluir progressivamente a amostra (1:1, 1:2, 1:4, 1:8...) até que o VDRL não seja mais reagente. O **título** é o resultado final, a última diluição em que ainda há reatividade.

**Atenção:** O VDRL é pouco específico, podendo positivar em doenças autoimunes (lúpus, síndrome antifosfolípide), gravidez, infecções virais (mononucleose, hepatite, HIV agudo) e vacinação recente.



### Raciocínio Diagnóstico Prático

Na unidade de saúde, comece pelo teste treponêmico (teste rápido). Se reagente, complemente com VDRL. Ambos reagentes? O paciente tem sífilis ou cicatriz sorológica – investigue tratamento prévio e critérios de cura.

Se o teste rápido for reagente e o VDRL não reagente, solicite um segundo teste treponêmico (CMIA ou FTA-Abs). Se este também for não reagente, era falso positivo. Se reagente, é sífilis ou cicatriz.

Se ambos os testes (treponêmico e não treponêmico) forem não reagentes, o exame é negativo para sífilis. Porém, se o paciente teve exposição de risco ou apresenta lesão suspeita, repita em 30 dias. Se a clínica for muito sugestiva, trate mesmo com exames negativos – **a clínica é soberana**.

**Mnemônico:** Um teste treponêmico reagente + um teste não treponêmico reagente = diagnóstico de sífilis.

---

### Tratamento da Sífilis

O tratamento varia conforme o estadiamento:

**Sífilis recente** (primária, secundária ou latente recente): **Penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades IM**, dose única (1,2 milhão em cada glúteo). Esta é uma atualização de 2023 – antes fazia-se esquema trisemanal para todos.

**Sífilis tardia** (latente tardia, indeterminada ou terciária): **Penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades IM**, uma vez por semana, por três semanas (dose total: 7,2 milhões de unidades).

**Alternativa** para alérgicos graves à penicilina: **Doxiciclina 100mg de 12/12h** – por 15 dias na sífilis recente e por 30 dias na tardia.

**Seguimento:** VDRL trimestral na população geral e **mensal em gestantes**.

**Ponto crucial:** A penicilina benzatina é o único tratamento seguro para gestantes. Qualquer outro esquema aumenta o risco de sífilis congênita. Em gestantes alérgicas, prefere-se a **dessensibilização para penicilina**. O mesmo vale para neurosífilis e sífilis congênita – são condições graves que justificam o tratamento de primeira linha.

### Reação de Jarisch-Herxheimer

É uma reação imune à destruição maciça de treponemas, ocorrendo nas primeiras 24 horas após a primeira dose de penicilina, principalmente nas fases primária e secundária. Manifesta-se com exacerbação das lesões cutâneas, mal-estar, febre e artralgia. O tratamento é **sintomático** (dipirona, compressas frias) e regride espontaneamente de 12 a 24 horas. Muitos pacientes confundem isso com alergia à penicilina – esclareça bem.

**Intervalo entre doses na sífilis tardia:** As doses devem ser semanais (a cada 7 dias). Se a gestante ultrapassar de **7 a 9 dias** entre as doses, reinicie o esquema do zero. Na população geral, o limite é 14 dias.

---

### Critérios de Cura

O objetivo não é zerar o VDRL, mas demonstrar **queda de duas diluições** (equivalente a quatro títulos). Exemplo: de 1:64 para 1:16 representa queda de duas diluições.

- **Sífilis recente:** queda de duas diluições em **6 meses**
- **Sífilis tardia:** queda de duas diluições em **12 meses**

O VDRL pode permanecer reagente em títulos baixos após o tratamento adequado – isso é **cicatriz sorológica**, não infecção ativa.

Para evitar reinfecção, **trate sempre as parcerias sexuais** com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades IM em dose única, independentemente do estágio clínico.

## Critérios para Retratamento

Retrate se: ausência de critérios de cura, aumento de duas ou mais diluições mantido por duas semanas, ou persistência/recorrência de sinais clínicos.

Investigue **neurossífilis** em pacientes sem chance de reinfecção que não atingiram critérios de cura, e em todas as pessoas vivendo com HIV com refratariedade ao tratamento.

---

## Aortite Sifilítica

Mais frequente na sífilis terciária, ocorre entre 10 a 30 anos após a infecção não tratada. Trata-se de inflamação crônica da parede aórtica, com quadro insidioso e assintomático até surgirem complicações graves: **insuficiência aórtica**, insuficiência cardíaca, dor torácica, **aneurisma de aorta ascendente**, estenose coronariana e infarto.

Suspeite em pacientes **sem doença aterosclerótica** que apresentam aneurisma de aorta ascendente ou insuficiência aórtica, com sorologia positiva para sífilis. O tratamento é o mesmo da sífilis terciária.

---

## Neurossífilis

Pode ser **precoce** (corresponde à sífilis recente) ou **tardia** (corresponde à sífilis tardia).

**Neurossífilis precoce** manifesta-se como:

- **Meningite:** cefaleia, febre, acometimento de pares cranianos

- **Vasculite:** pequenas e grandes artérias, classicamente a cerebral média. Pense nisso em **paciente jovem com AVC sem fatores de risco**
- **Sífilis ocular:** panuveíte com vitreíte, moscas volantes, redução da acuidade visual
- **Otossífilis:** perda auditiva com zumbido uni ou bilateral

**Neurossífilis tardia** apresenta:

- **Tabes dorsalis:** desmielinização dos cornos posteriores da medula, causando ataxia sensorial, redução de reflexos, disfunção intestinal e vesical, dor abdominal
- **Demência sífilítica:** sintomas neuropsiquiátricos graves por encefalite crônica
- **Goma sífilítica:** lesões granulomatosas necróticas no SNC, gerando déficits focais (diferencial com tumores)
- **Pupilas de Argyll Robertson:** pupilas que **não reagem à luz**, mas **fazem miose à acomodação**

## Diagnóstico de Neurossífilis

Paciente com sífilis atual ou prévia, falha terapêutica, alterações no exame de imagem ou presença de gomas. O líquido com qualquer alteração em paciente com sífilis deve levantar suspeita. Trate todos os casos com VDRL reagente no líquido ou alterações bioquímicas/sintomas compatíveis não explicados por outra doença.

**Tratamento: Penicilina G cristalina 4 milhões de unidades EV, de 4/4h, por 14 dias** (mnemônico: **4-4-14**). Necessita internação hospitalar.

**Seguimento:** Punções lombares aos 3, 6, 12 e 24 meses. O VDRL no líquido deve cair duas diluições em 6 a 24 meses e negativar ou estabilizar em valores baixos em 2 anos. O VDRL sérico deve cair duas diluições em 24 meses. Pleocitose e proteinorraquia devem começar a declinar em 6 meses e normalizar em 24 meses.



## Sífilis na Gestante

Toda gestante deve ser testada para sífilis na primeira consulta de pré-natal, no início do terceiro trimestre, na internação para o parto e após qualquer exposição de risco. Trate imediatamente ao diagnóstico — não deixe para a próxima consulta.

O monitoramento é **mensal até o termo e trimestral após o parto até o 12º mês**. Sempre trate o parceiro.

A maior eficácia na redução da transmissão vertical ocorre quando o tratamento é instituído **antes de 28 semanas**. Tratar após 28 semanas reduz o risco, mas não o elimina.

**Cenários de maior risco de transmissão vertical:** sífilis primária e secundária (maior carga de treponemas) e sífilis no terceiro trimestre.

**Importante:** Investigue todos os recém-nascidos de mães com diagnóstico de sífilis durante a gestação, mesmo que tenha havido tratamento adequado e critérios de cura.

---

## Cancroide (Cancro Mole)

Causado pelo **Haemophilus ducreyi**, também é conhecido como cancro venéreo ou cancro de Ducrey. O período de incubação é de 3 a 5 dias, podendo chegar a duas semanas. Predomina em homens.

O quadro clínico caracteriza-se por **lesões múltiplas** (por autoinoculação), com borda irregular e fundo com exsudato necrótico. Quando removido, revela tecido de granulação sangrante. A bactéria dissemina-se para os linfonodos inguinais, formando um **bubão unilateral** cheio de pus que **fistuliza por orifício único** — pense em um funil.

**Mnemônico:** Cancroide = lesões múltiplas + bubão que fistuliza em **funil** (orifício único).

**Diagnóstico:** Clínico. A microscopia pode mostrar o bacilo gram-negativo em "cardume de peixe", mas o resultado negativo não descarta o diagnóstico.

**Tratamento:** Azitromicina 1g VO em dose única ou Ceftriaxona 250mg IM em dose única. Trate as parcerias sexuais.

---

### Linfogranuloma Venéreo

Causado pela **Chlamydia trachomatis**, é uma doença invasiva do tecido linfático com várias fases evolutivas.

Inicia-se com **pápula indolor** no local de inoculação, que desaparece sem sequelas. Após 1 a 6 semanas, a disseminação linfática causa **linfadenopatia inguinal unilateral** (bubão). O linfonodo supura e **fistuliza em múltiplos orifícios** – pense em um bico de regador ou chuveiro.

Podem ocorrer fusão de massas linfonodais e intensos **sintomas sistêmicos**: mal-estar, febre, artralgia, glossite e **proctocolite com estenose retal**. Na fase crônica, a obstrução linfática causa **elefantíase genital**.

**Mnemônico:** Linfogranuloma venéreo = bubão que fistuliza em **bico de regador** (múltiplos orifícios).

**Diagnóstico:** Clínico.

**Tratamento:** Doxiciclina 100mg de 12/12h por 21 dias. Alternativa: azitromicina por 21 dias.

**Atenção:** As sequelas (elefantíase genital e estenose retal) são irreversíveis mesmo com tratamento.

## Herpes Genital

Causado pelo **Herpesvírus tipo 1** (principalmente perioral) e **tipo 2** (principalmente genital). A lesão típica é uma **pápula eritematosa que evolui para vesícula sobre base eritematosa**, muito dolorosa. Ao romper, libera conteúdo citrino (amarelo-alaranjado).

A **primoinfecção** é mais intensa, com sintomas sistêmicos e linfonodomegalia inguinal dolorosa. As **recorrências** são mais brandas. Fatores desencadeantes incluem: nova infecção, exposição solar, traumatismo local, menstruação, estresse, antibioticoterapia prolongada e imunossupressão.

**Diagnóstico:** Clínico. O **teste de Tzanck** (esfregão da vesícula mostrando células multinucleadas gigantes) indica infecção herpética, mas não diferencia HSV-1 de HSV-2.

### Tratamento:

- **Primeiro episódio:** Aciclovir 400mg VO de 8/8h por 7 dias (ou até cicatrização)
- **Recidiva:** Aciclovir 400mg VO de 8/8h por 5 dias
- **Terapia supressiva** ( $\geq 6$  episódios/ano): Aciclovir 400mg VO de 12/12h por 6 meses a 2 anos
- **Imunossuprimidos:** Aciclovir 5-10mg/kg EV de 8/8h por 7 dias
- **Gestantes:** Tratar como primoinfecção em qualquer trimestre. Se recidivas frequentes, terapia supressiva a partir de 36 semanas com aciclovir 400mg de 8/8h

### Donovanose

Causada pela **Klebsiella granulomatis**, é uma IST crônica de pele e mucosa genital, perianal e inguinal. Apresenta baixa transmissibilidade, sendo mais comum em surtos ou em pacientes com condições precárias ou imunossuprimidos.

O quadro clínico é característico: úlcera de fundo granuloso com fácil sangramento, evolução lenta até o estágio ulcerovegetativo, com **lesões múltiplas bilaterais "em espelho"**. Pode haver **pseudobubões** (granulações subcutâneas, não são linfonodos verdadeiros) e, tardiamente, elefantíase genital.

**Diagnóstico:** Clínico.

**Tratamento:** Azitromicina 1g VO semanal por 3 semanas ou Doxiciclina 100mg de 12/12h por 21 dias. Em HIV positivos ou se não houver melhora, associe gentamicina. Sequelas podem necessitar de correção cirúrgica.

---

### Comparativo das Adenomegalias nas Úlceras Genitais

| Doença                 | Dor | Lateralidade | Fistulização       |
|------------------------|-----|--------------|--------------------|
| Sífilis                | Não | Bilateral    | Não                |
| Herpes                 | Sim | Bilateral    | Não                |
| Cancroide              | Sim | Unilateral   | Única (funil)      |
| Linfogranuloma venéreo | Sim | Unilateral   | Múltipla (regador) |

---



## Uretrites e Cervicites

### Uretrite Gonocócica

Causada pela **Neisseria gonorrhoeae** (diplococo gram-negativo). O quadro clínico inclui uretrite, cervicite, proctite, faringite e conjuntivite purulenta – depende do local de inoculação. O corrimento é **mucoपुरulento e agudo**, com balanite.

Frequentemente causa **doença extragenital hematogênica**: monoartrite, tenossinovite séptica, febre e lesões cutâneas. **Paciente jovem com monoartrite deve levantar suspeita de artrite gonocócica.**

### Uretrite Não Gonocócica

Cerca de 50% é causada por **Chlamydia trachomatis**; o restante por mycoplasma, tricomonas e ureaplasma. O quadro é mais brando: **corrimento mucoide, disúria leve e intermitente**, apresentação subaguda e arrastada.

**Dica prática:** Homem com disúria raramente tem ITU. Se ardeu para urinar, pense em uretrite ou cálculo ureteral. **Homem com disúria = IST até prova em contrário.**

Complicações incluem prostatite, epididimite, balanite, conjuntivite e **síndrome de Reiter**.

**Diagnóstico:** PCR para gonococo e clamídia, microscopia com coloração de Gram, cultura para gonococo. No exame de urina tipo 1, leucoesterase positiva com piúria sugere uretrite.

### Tratamento:

- **Uretrite sem agente identificado: Ceftriaxona 500mg IM + Azitromicina 1g VO**, ambos em dose única. Trate parcerias e oriente abstinência sexual por 7 dias.
- **Gonocócica confirmada:** Ceftriaxona + Azitromicina em dose única
- **Por clamídia confirmada:** Azitromicina 1g VO em dose única

- **Infecção gonocócica disseminada:** Ceftriaxona 1g EV/dia por 7 dias + Azitromicina dose única
- **Conjuntivite gonocócica:** Ceftriaxona dose única

Reavalie em 7 a 10 dias. Se persistir secreção, considere reexposição, outros agentes (ureaplasma), ITU, prostatite ou fimose.

---

### Síndrome de Reiter

Tríade de **artrite reativa asséptica + conjuntivite + uretrite**. Predomina em homens de 20 a 30 anos, frequentemente associada ao **HLA-B27**. Pode acompanhar-se de **ceratoderma blenorrágico** (lesões úlcero-crostosas em palmas e plantas) e **balanite circinada** (lesão arredondada na glândula).

**Diagnóstico:** Clínico.

**Tratamento:** AINEs em dose máxima.

---

### Condiloma Acuminado (HPV)

O **Papilomavírus humano (HPV)** é um DNA vírus. Apenas 1-2% das infecções causam verrugas anogenitais; a maioria é subclínica, causando as lesões pré-neoplásicas (NICs e NIVs) abordadas em ginecologia.

Os **HPVs de baixo risco oncogênico** (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81) são os responsáveis pelas verrugas genitais.

**Diagnóstico:** Clínico (aspecto de "couve-flor"). Biópsia em casos de dúvida diagnóstica ou imunossupressão. O PCR de DNA-HPV pode ser realizado durante o exame preventivo.

## Tratamento:

- **Domiciliar:** Imiquimode ou podofilotoxina
- **Ambulatorial:** Ácido tricloroacético (ATA), podofilina, eletrocauterização ou crioterapia

Prefira tratamento ambulatorial para lesões grandes, numerosas, atípicas ou em mucosas.

## Mpox

A **Mpox** (antiga Monkeypox) é causada pelo **Mpox vírus**, com transmissão por sangue, fluidos corporais, lesões de pele, **gotículas** e via transplacentária.

O quadro clínico típico inicia com **pródromo** de febre, adenomegalia, mialgia e cefaleia por 1 a 5 dias, seguido de **erupções cutâneas dolorosas na mesma fase de evolução**: máculas que evoluem para vesículas, depois pústulas, crostas e cicatrização.

**Complicações** (principalmente em imunossuprimidos): balanopostite, **proctite** (mais comum), lesões necrotizantes e, em HIV/AIDS, comprometimento visceral (ocular, encefalite, sepse por infecções oportunistas).

**Diagnóstico:** Clínico + PCR.

**Tratamento:** Sintomáticos. O **tecovirimat**, antiviral que era promissor, não foi aprovado pela ANVISA e recentemente (novembro de 2025) uma metanálise demonstrou ausência de benefício em relação ao placebo, além de aumentar o risco de efeitos colaterais como injúria renal aguda.

## Imunização:

- **PrEP:** Pessoas vivendo com HIV (homens cis, travestis e mulheres trans entre 18-49 anos) e profissionais de laboratório que trabalham com o vírus
- **PEP:** Pessoas com contato direto com fluidos/secreções de casos suspeitos, prováveis ou confirmados

**Observação:** A vacina está com estoque crítico atualmente.

---

## Resumo Prático para Prova

### Úlceras genitais:

- Vesículas = Herpes genital (aciclovir)
- Única, indolor = Sífilis primária
- Múltiplas, dolorosas, bubão com fístula única = Cancroide (azitromicina)
- 4 semanas, fistulização múltipla = Linfogranuloma venéreo (doxiciclina)
- Lesão extensa em espelho = Donovanose (azitromicina)

### Adenopatia:

- Unilateral = Cancroide ou Linfogranuloma venéreo
- Bilateral = Sífilis (indolor) ou Herpes (dolorosa)

### Uretrites:

- Gonocócica = Corrimento mucopurulento agudo, monoartrite em jovem
- Não gonocócica = Corrimento mucoide arrastado
- Homem com disúria = Sempre pensar em uretrite infecciosa

### Sífilis:

- Recente: Benzetacil 2,4 milhões UI dose única
- Tardia: Benzetacil 2,4 milhões UI semanal por 3 semanas



- Neurosífilis: Penicilina cristalina 4 milhões UI EV 4/4h por 14 dias (4-4-14)
- Cura: Queda de 2 diluições em 6 meses (recente) ou 12 meses (tardia)

